专题串联·心律失常的治疗原则和常考心电图

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



一般上起搏器,没条件可先上阿托品和异丙肾上腺素(有急性心肌梗死不能用)

先判断是快速型心律失常还是缓慢型心律失常　（一）治疗大原则

1.偶发、无症状等“小场面”（如房早、一度和二度I型房室阻滞）多无需治疗，应先观察找病因 或治疗原发病即可

（注意：房颤最佳为导管消融根治）孤立性房颤也是“小场面”:可以选择先观察(首选),但最佳治疗是导管消融

房颤怕栓怕快

通道失活与平台期有关,平台期越长,通道失活时间越长
心房肌的平台期很短→钠通道失活的时间短→利多卡因对心房效果差

2.否则 ttsx

（1）“血压正常我用药”

强心苷抑制钠泵→膜电位↓→与阈电位距离变近→距离过近时会导致去极化阻滞(钠通道失活)

房室结 ⇄ Kent束 → 房颤伴预激　xianBB点心(抑制房室结)都不能用于房颤伴预激

利多卡因	急性心梗或强心苷中毒所致室早 更主要抑制失活态的快钠通道(缺血时、强心苷中毒时)
普罗帕酮 有明显负性肌力作用	无器质性心脏病的房扑房颤、阵发性室上速、~~预激综合征~~ 房颤伴预激
β-R 拮抗剂 yyds	房扑房颤（控心率首选）、阵发性室上速等 房颤伴预激不能用(直接用普通的伊布)
胺碘酮 yyds 主要转复	房扑房颤、阵发性室上速、急性心梗所致室早等
伊布利特	房扑房颤、预激综合征伴房扑房颤（首选电复律）
维拉帕米/地尔硫卓	房扑房颤、阵发性室上速
腺苷	阵发性室上速（药物首选）
强心苷	伴房扑房颤、阵发性室上速的**收缩性心衰** 收缩性心衰合并AVNRT或房颤用β-R拮抗剂更好

AVNRT

（2）快速型：“血压低我电击”（**休克首选电复律**）

室上速 ┬ 非阵发←强心苷中毒
　　└ 阵发(折返) ┬ AVNRT(⭐):折返环位于房室结
　　　　└ AVRT:折返环由心房心室旁路房室结一起构成

R 波存在→**同步**直流电复律；R 波不存在→**非**同步直流电复律/电除颤（**室扑室颤**）

10 版教材 P222：电复律是快速房扑的首选治疗

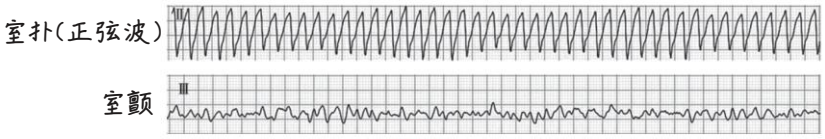


图 3-3-25　心室扑动与心室颤动

Ⅱ导联呈连续的波动，形似正弦波，频率 250 次/分，无法分辨 QRS 波群、ST 段及 T 波，为心室扑动；
Ⅲ导联呈形态、振幅各异的不规则波动，频率约 300 次/分，QRS-T 波群消失，为心室颤动。

注意禁忌症	非二氢吡啶类CCB有负性肌力作用(禁用于收缩性心衰)				
	腺苷	β-R拮抗剂	IV	胺碘酮	强心苷
AVNRT	√(首)	√	√	√	√
收缩性心衰合并AVNRT		√(更好)			√
AVRT	√	√	√	√	会缩短旁路不应期
预激伴房颤	×	×	×	×	×
房颤		√控心率	√控心率	√转复 也可以控心率,主要是	√控心率
收缩性心衰伴房颤		√(更好)			√
急性心梗导致的室早室速		√预防远期风险 ①缩小梗死面积②预防恶性心律失常的发生		√已经发作了	

最好直接电复律,没条件就上普通的伊布

转复用普通的伊布、胺碘酮

利多卡因用于:急性心梗/强心苷导致的室早室速

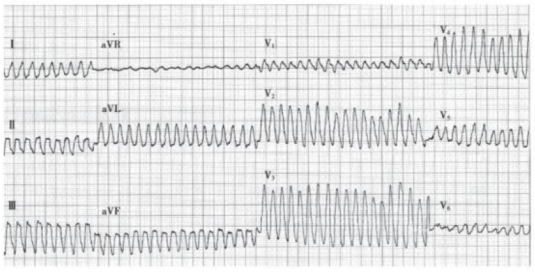


图 5-1-75　心室扑动



图 5-1-76　心室颤动